

Предоперационная химиоинфузия в бронхиальную артерию в комплексном лечении немелкоклеточного рака легкого III стадии

О.К. Кулакеев*, С.Е. Оспанов**, Д.Т. Арыбжанов***

*Международный Казахско-Турецкий университет, г. Туркестан,

**Областной онкологический центр, г. Кызылорда,

***Южно-Казахстанский областной онкологический диспансер, г. Шымкент

Өкпенің жасушалы емес қатерлі ісігінің комплексті емдеудегі брохиалды артерияға қолданылатын химиотерапия

О.Қ. Кулакеев, С.Е. Оспанов, Д.Т. Арыбжанов

Мақалада өкпенің жасушалы емес қатерлі ісігінің неoadъювантты химиотерапия 50 науқасқа жүргізілгені кең түрде көрсетілген, 11 (22%) өкпенің барлық және ателектаз зақымдаған бөлігінің біріншілік кеуі орын алды. Морфологиялық өкпенің желпар жасушам 36 (27%) кездессе, 14 (28) аденокарцинома барлық науқастарға ем цикл бойынша неoadъювантты ПХТ жүргізілді 21

(76%) науқастың химиотерапия бірінші курсы процестің бөшктік регрессиясы. Ал 38(76%) ем курс химиотерапиядан науқастарда бөліктік регрессия байланды. 50 35 (70%) оталық ем қолданған. 35 жасалынған ота науқастың 25 кенейтімен. Ал 10 интраперикардпен, перикард резекциясының пульмоноэктомиясы, окпе түбірі тамырында байланған жекелей кездесті. Цитостатиктерің артерия енгізуі емдеу 10-15% нәтижелерің жақсартады, таңдалған бағдарламасы бойынша емдеудің тиімді аяқталуын етеуі.

Рак легкого (РЛ) — широко распространенное заболевание. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями РЛ в мире занимает 1-е место [1, 3, 5]. Показатель заболеваемости раком легкого населения России в 1997 г. был 44,69 на 100 000 населения, в 2007 г. - 40,2 на 100 000 населения. Если в 1970 году в республике Казахстан заболеваемость раком легкого составила 15,2‰, то к 2007 году она выросла до 22,6‰ и в структуре онкологической заболеваемости с 1985 года занимает 1-ое место [1, 3]. Мужчины заболевают в 5—8 раз чаще женщин. Наиболее часто заболевание регистрируется в возрасте 50 лет и старше. Летальность больных в течение первого года с момента установления диагноза составляет в разных странах от 55,3% до 80% [2, 6, 8, 9].

Среди гистологических форм основную массу больных РЛ составляет немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет около 78-84%. Учитывая, что более половины больных НМРЛ уже неоперабельны на момент установления диагноза, либо в связи с местно-распространенным процессом, либо в связи с наличием отдаленных метастазов, очевидна актуальность разработки методов лекарственной терапии этой формы рака. В настоящее время лекарственная терапия НМРЛ - одна из наиболее динамично развивающихся разделов химиотерапии опухолевых заболеваний. Мета-анализ индивидуальных данных 11 рандомизированных исследований показал, что использование платиносодержащих комбинаций в сочетании с лучевой на 10% снижает риск смерти у больных НМРЛ по сравнению с одной лучевой терапией [4, 7, 10, 12]. Эффективным оказалось использование комбинированной химиотерапии, включающей производные платины в плане неoadъювантной (предоперационной) химиотерапии у больных НМРЛ IIIa,б стадии. Предоперационная химиотерапия, как было показано в рандомизированных исследованиях, более чем в 3 раза увеличивает выживаемость больных, получивших перед операцией 3 курса платиносодержащей комбинированной химиотерапии, по сравнению с контрольной группой, подвергшейся лишь операции [13, 14, 15].

Учитывая вышеизложенное авторами произведена попытка применения предоперационной химиотерапии у больных раком легкого III стадии с применением ре-

гионарного введения цитостатиков в бронхиальную артерию.

Целью

нашей работы является изучение непосредственных результатов комбинированного лечения больных НМРЛ с применением неoadъювантной химиотерапии за 5 (2004-2009 гг.) лет.

Материал и

методы

Начиная с июня 2004 года мы имеем практический опыт лечения 50 больных с местно распространенным, центральным раком легкого (Т3N1-2M0) в возрасте 42-65 лет. У 11 (22%) больных при первичном обращении имел место ателектаз пораженной доли или всего легкого. Морфологически в 36 (72%) случаях был плоскоклеточный рак легкого, в 14 (28%) случаях аденокарцинома. Всем больным из-за сомнений операбельности процесса было проведено по два цикла неoadъювантной полихимиотерапии. У 4 (8%) больных по схеме EP: Вепезид 120 мг/м², Цисплатин 80 мг/м² с дополнением длительной инфузией 5-фторурацила 5000мг в течении 120 часов, у 24 (48%) больных по схеме TP: Таксотер 75мг/м², Цисплатин 75 мг/м², у 22 (44%) больных по схеме EP: Вепезид 120мг/м², Цисплатин 80 мг/м². При этом у 20 (40%) больных было произведено внутриаrтериальное, регионарное введение препаратов с селективной катетеризацией бронхиальной артерии (рис. 1).



Рисунок 1. Селективная катетеризация бронхиальной артерии пациента М. -52 года с диагнозом центральный рак правого легкого Т3N1M0, III St. Ангиограмма а. Brochialis справа.



Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет (до лечения). Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Левосторонний плеврит с ателектазом легкого.



Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет (после предоперационной химиотерапии).

Результаты

При контрольном осмотре после одного курса химиотерапии у 21 (42%) больных рентгенологически отмечена частичная регрессия процесса, в том числе у 3 (6%) больных восстановление дыхательной функции легких в ранее ателектазированных участках, у 29 (58%) больных стабилизация процесса. После 2х курсов химиотерапии у 38 (76%) больных отмечена частичная регрессия процесса, эндоскопически у 14 (28%) проходимость бронхов восстановлена до сегментарных бронхов (Рис. 2, 3, 4). Рентгенологически отмечена возможность операбельности процесса во всех 38 случаях. Из 50 больных подвергнуты хирургическому лечению 35 (70%) больных (у 3-х больных отмечено противопоказание к хирургическому вмешательству в связи с присоединением сопутствующей сердечно-сосудистой патологии). Из 35 оперированных больных в 25 случаях произведена расширенная пульмонэктомия, а 10 случаях комбинированно-расширенная пульмонэктомия с резекцией перикарда с интраперикардиальной, раздельной обработкой сосудов корня легкого. Послеоперационный период во всех случаях протекал без особенностей. Послеоперационный результат гистологического исследования во всех случаях показал лекарственный патоморфоз III-IV степени. 3 больных в послеоперационном периоде получили лучевую терапию по радикальной программе. В раннем послеоперационном периоде умерла 1 больная из-за нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности. После хирургического этапа все больные получили лучевую терапию на область средостения РОД 2Грей, СОД 45-50 Грей. Затем еще по 2-4 консолидирующих курсов химиотерапии по той же схеме, то и до операции.

Выводы. Таким образом, использование новых противоопухолевых препаратов, в первую очередь, ингибиторов топоизомеразы 1 (Этопозид) и таксанов в сочетании с производными платины позволило повысить операбельность больных с распространенным НМРЛ. Производные платины пока остаются основой современной комбинированной химиотерапии НМРЛ. Однако предоперационная неoadъювантная химиотерапия и химиолучевая терапия с последующей операцией могут считаться апробированным методом и рассматриваться как один из вариантов лечения при III стадии НМРЛ. Применение цитостатиков в режиме внутриартериального введения может улучшить непосредственные результаты лечения на 10-15%, что даст возможность эффективно закончить лечение по выбранной программе.



Рисунок 4. Обзорная рентгенограмма больного Ш. – 65 лет (после пульмонэктомии через 2 года). Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Состояние после комбинированной терапии.

Диагноз: центральный рак левого легкого T3N2M0, III-б St. Частичная регрессия процесса.

Литература

1. Абисатов Х.А. – Клиническая онкология (руководство), Алматы, изд. «Арыс», 2007 с.1240 с.
2. Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е. – Рак легкого. М. «Радикс», 1994, с.210
3. Кулакев О.К., Арыбжанов Д.Т., Юсупов А.М. и др. Эффективность неoadъювантной химиотерапии немелкоклеточного рака легкого // В Сб. Республ. Научно-практич. Конференции «Актуальные проблемы клинической онкологии», Семей, 2007, С 150-151
4. Кулакев О.К., Арыбжанов Д.Т., Султанов Р.Р. Результаты лечения рака легкого // Вестник хирургии Казахстана, №3, Алматы, -2005, -С. 113.
5. Онкология. Клинические рекомендации. Под редакцией В.И.Чиссова и С.П.Дарьяловой, Москва. ГЭОТАР - «Медиа», 2006.с. 193-230.
6. Орлова Р.В. Современное стандартное лечение больных немелкоклеточным раком легкого с учетом стадии заболевания // Практическая онкология. – 2000, №3. – С. 17-20.
7. Переводчикова Н.И. Химиотерапия немелкоклеточного рака легкого – состояние проблемы в 2000г. // Практическая онкология. - 2000, №3. – С. 29-37.
8. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. Москва. ГЭОТАР «Медицина», 2000 – 600 с.
9. Харченко В.П., Кузьмин И.В. Рак легкого. М, 2Медицина», 1994 с.480.

10. Burkhart N.M., Allen M.S., Nichols F.C., et. al. Results of en bloc resection for bronchogenic carcinoma with chest wall invasion. //J. Thorac. Cardiovasc. Surg, 2002, vol.123. p.670-675
11. Curan W.J. Issues in the nonoperative management of patients with locally advanced non-small cell lung cancer// Proc. ASCO. - 1999. - Educational book/Ed. M.C. Perry; ASCO. -1999. -P.370-373.
12. Holmes A.C. Surgical adjuvant therapy for stage II and stage III adenocarcinoma and large cell undifferentiated carcinoma// Chest. -1994. -Vol. 106 (6 suppl). -P. 293-296 .
13. Gumerlock P.H. Molecular-clinical correlative studies in non-small cell lung carcinoma.//ASCO.—1999.—Educational book/ Ed.- M.C. Perry; ASCO.-1999.-P.374-381.
14. Kelly K. Future Directions for New Cytotoxic Agents in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer// Proc. ASCO. — 2000. — Educational book. -P. 357-367.
15. Marsiglia H., Baldeyrou P., Lartigau E. et.al. //High-dose-rate brachytherapy as sole modality for early-stage endobronchial carcinoma// Inter. J. Radiat, Oncol, Biol, Phys, 2000, vol.47, p.665-672.